



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN BULANAN
PROGRAM GIZI TERKAIT PENURUNAN PREVALENSI STUNTING
DAN WASTING
JUNI 2025**

1. Pola Ketenagaan

1.1 Jumlah SDM

Tabel 1.1 Jumlah SDM Tim Penurunan Prevalensi stunting dan wasting Juni 2025

Jabatan	Jumlah SDM			
	Standar	April '25	Mei '25	Juni '25
Ketua Tim Stunting dan wasting	1	1	1	1
Sekretaris program stunting dan wasting	1	1	1	1
Anggota Tim Stunting Dan Wasting	5	6	6	6

1.2 Pemenuhan Kualifikasi SDM

Tabel 1.2 Kualifikasi SDM Tim Stunting dan Wasting Juni 2025

Jabatan	Kualifikasi	April '25	Mei '25	Juni '25
Ketua Tim Stunting dan wasting	Dokter spesialis Anak	1	1	1
Sekretaris program stunting dan wasting	D4 Gizi	1	1	1
Petugas Gizi	S1	1	1	1
Perawat IRJA Anak	D3	2	2	2
Perawat IRNA Anak	D3	1	1	1
Perawat Perinatologi	S1	1	1	1
Apoteker	S1	1	1	1

Analisis :

- Jumlah tim stunting dan wasting keseluruhan berjumlah 8 orang. Terdiri dari 1 ketua, 1 sekretaris dan 6 anggota.
- Seluruh tim stunting dan wasting memiliki SIK, SIP, dan STR yang masih berlaku
- Tim Penurunan prevalensi stunting dan wasting secara keseluruhan sudah memiliki SIP, STR maupun SIK yang masih berlaku.

Rencana Tindak Lanjut :

- Koordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten malang untuk mengembangkan pelayanan serta melakukan pelatihan eksternal terkait program penurunan prevalensi stunting dan wasting.

2. Kegiatan Bulan Juni 2025 Tim Stunting dan Wasting

Tabel 2. Kegiatan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting bulan Juni 2025

No	Kegiatan Pokok SDM	Pemenuhan Rencana Kegiatan
1	Kebutuhan SDM	Terdapat perubahan tim stunting dan wasting pada bulan Juni 2025.
2	Orientasi	Terdapat orientasi pada anggota tim penurunan prevalensi stunting dan wasting pada bulan Juni 2025.
3	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan tentang stunting dan wasting dilakukan untuk memberikan pengetahuan mengenai stunting dan wasting serta dampak dan faktor penyebab dari stunting dan wasting dimana materi disampaikan oleh ketua tim setiap rapat bulanan. Pendidikan dan pelatihan kepada staff RS Prima Husada tentang stunting wasting belum dilakukan pada tahun 2025.
4	Evaluasi Kinerja	- Melakukan penyuluhan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan berkaitan dengan intervensi spesifik dan pencegahan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pasien dan keluarga pasien tentang stunting dan wasting. - Melakukan beberapa intervensi spesifik yang dapat dilaksanakan di rumah sakit yaitu promosi tentang program 1000 HPK, Suplementasi tablet besi folat, Pemberian PMT pada ibu hamil, promosi konseling IMD dan ASI eksklusif, Pemberian makanan bayi dan anak, pemantauan pertumbuhan, dan pemberian makanan tambahan balita gizi kurang. - ASI Eksklusif - Edukasi Pemberian ASI eksklusif sudah terlaksana dengan baik, - Dibentuknya Grup pendukung ASI eksklusif - Senam Hamil - Senam Hamil dilaksanakan 2x dalam 1 bulan secara rutin - Pemberian edukasi seputar kesehatan atau perawatan - perawatan yang dibutuhkan ibu hamil. - Merujuk pasien stunting kepada puskesmas wilayah tempat tinggal balita stunting dan wasting untuk evaluasi pertumbuhan dan perkembangan balita melalui whatsapp dan aplikasi eppgbm

3. Fasilitas Sarana dan Prasarana Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting RSPHM

No	Jenis Ruangan	Keterangan	Kondisi
1.	R. Rawat Jalan Anak	Tersedia	Baik Siap Pakai
2.	Poli Gizi	Tersedia	Baik Siap Pakai
3.	R. rawat inap anak	Tersedia	Baik Siap Pakai

No	Jenis Peralatan Non Medis	Keterangan	Jumlah	Kondisi
1.	Timbangan Berat dan Panjang Badan Bayi	Tersedia	2	Baik Siap Pakai
2.	Timbangan Berat Badan Balita	Tersedia	3	Baik Siap Pakai
3.	Alat ukur Tinggi Badan Balita	Tersedia	3	Baik Siap Pakai
Media Konseling dan Promosi Kesehatan				
4.	X-Banner	Tersedia	1	Baik Siap Pakai
5.	Leaflet	Tersedia (soft file/online)	Tersedia	Baik Siap Pakai

Analisis :

- Secara keseluruhan kondisi sarana prasarana tim stunting dan wasting sudah tersedia dengan lengkap.
- Apabila ada alat yang rusak akan diperbaiki oleh tim IPSRS.
- Pada bulan Juni tidak ada jadwal kalibrasi

Rencana Tindak Lanjut :

Koordinasi dengan tim IPSRS untuk melakukan kalibrasi pada alat ukur berat badan dan panjang badan bayi.

4. Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting RSPHM

Tabel 4. Pelayanan Tim Penurunan Prevalensi Stunting dan Wasting Juni 2025

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan
1	Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staf , pasien, dan keluarga tentang masalah stunting dan wasting	Melakukan promosi kesehatan dengan melaksanakan edukasi pasien dan sosialisasi kepada seluruh staff mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan stunting dan wasting.
2	Program 1000 HPK	Pemberian Penyuluhan tentang pentingnya pengasuhan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien
3	Suplementasi Folat Pada Ibu hamil	Suplementasi Folat Pada ibu hamil dilaksanakan di poli kandungan di RS Prima Husada Malang
4	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada ibu hamil	Pemberian PMT pada ibu hamil dilaksanakan pada saat kegiatan senam hamil di RS Prima Husada Malang

5	Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	1. Kegiatan konseling IMD dilaksanakan sesaat setelah ibu melahirkan 2. Konseling IMD dan ASI eksklusif dilaksanakan pada saat ibu telah memasuki rawat inap maternitas 3. Penyuluhan tentang pentingnya IMD dan pemberian ASI eksklusif juga dilaksanakan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan
6	Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Pemantauan pertumbuhan bayi dan balita dilaksanakan di ruang rawat inap dan melakukan pendampingan di poli anak RS prima husada
8	Pemberian imunisasi	Pemberian imunisasi dilaksanakan di poli anak RS prima husada malang sesuai dengan jadwal praktek dokter spesialis anak dan di rawat inap sesaat setelah bayi baru dilahirkan.
9	Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Pemberian makanan tambahan balita gizi kurang dilaksanakan apabila ditemui balita dengan gizi kurang di rawat inap
10	Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi	1. Menyelenggarakan pelayanan konseling kesehatan maternal dan neonatal. 2. Konseling pemberian ASI eksklusif. 3. Penyediaan Pojok Laktasi untuk mendukung pemberian ASI eksklusif
11	Rumah Sakit sebagai pusat rujukan kasus stunting dan wasting	1. Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Stunting, Gizi Kurang, Gizi Buruk pada Balita 2. Memastikan kasus, penyebab dan tatalaksana lanjut oleh dokter spesialis anak. 3. Melakukan evaluasi pelayanan, audit kesakitan dan kematian, pencatatan dan pelaporan gizi buruk dan stunting.
12	Rumah Sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen serta merupakan jejaring rujukan	Tidak terdapat kunjungan/ Pendampingan klinis kepada balita gizi kurang yang telah KRS dari RSPHM.
13	Program Pemantauan dan Evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait edukasi yang sudah diberikan, serta membuat laporan dan evaluasi kegiatan.

Analisis

- 1) Melakukan tindakan pelayanan penurunan dan penanggulangan stunting dan wasting di rumah sakit.
- 2) Melakukan edukasi mengenai pencegahan dan penanggulangan stunting dan wasting kepada pengunjung, pasien, dan keluarga pasien di rumah sakit.

5.Kinerja Produktivitas

Tabel 5.1 Peningkatan efektifitas intervensi gizi spesifik

Program	Kegiatan	Sasaran	Lokasi	April	Mei	Juni
---------	----------	---------	--------	-------	-----	------

				2025	2025	2025
Program 1000 HPK	Penyuluhan mengenai kehidupan 1000 hari pertama	Pengunjung RS Prima Husada Malang	IRJA anak dan Kandungan	1	1	1
Suplementasi Asam folat pada ibu hamil	1. Penyuluhan tentang pentingnya konsumsi asam folat pada ibu hamil 2. Pembagian tablet tambahan darah dan asam folat	Ibu Hamil	Senam Hamil , Poli Kandungan, Hall gedung baru lantai 5	1	1	1
Pemberian PMT Ibu Hamil	Pemberian PMT dengan tinggi kalori terutama pada ibu hamil terindikasi KEK	Ibu Hamil	Hall gedung baru lantai 5	1	1	1
Promosi dan konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif	Penyuluhan mengenai pentingnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI	Ibu hamil	IRJA anak dan kandungan, irna maternitas	1	1	1

	eksklusif					
Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	1. Penyuluhan tentang stunting, makanan sehat pada bayi dan balita 2. Pembagian PMBA	IRNA Anak	IRJA	1	1	1
Pemantauan pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Melakukan Pencatatan dan plotting pada buku KIA setelah pengukuran berat badan dan tinggi badan anak	Pasien Anak	IRJA anak	1	1	1
Pemberian Imunisasi	Memastikan ketersediaan imunisasi agar selalu tersedia di poli anak	Pasien anak dan Bayi baru lahir	IRJA anak	1	1	1
Pemberian vitamin A	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung	Pasien anak	IRJA anak	0	0	0

	program pemerintah mengenai pemberian vitamin A					
Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurang	Memberikan PMT tinggi kalori dengan membantu menyusun menu yang sesuai dengan ketersediaan bahan pangan di lingkungan	Pasien anak	Rawat Inap	1	1	1
Pemberian Taburia pada Baduta	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian bubuk taburia	Pasien anak	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0
Pemberian Obat cacing pada ibu hamil	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung	Ibu Hamil	Rawat Inap dan Rawat Jalan	0	0	0

	program pemerintah mengenai pemberian obat cacing pada ibu hamil					
--	--	--	--	--	--	--

Analisis :

Sebagian besar intervensi spesifik yang dapat dilaksanakan di rumah sakit telah dilaksanakan. Pemberian bubuk Taburia dan Mineral mix dilakukan pemberian kepada pasien apabila terdapat pasien rujukan dari puskesmas. Karena bubuk taburia dan mineral mix hanya terdapat di puskesmas. Sehingga jika ada pasien teridentifikasi wasting pihak RS baru mendapat distribusi dari puskesmas wilayah balita tersebut tinggal.

Rencana Tindak Lanjut :

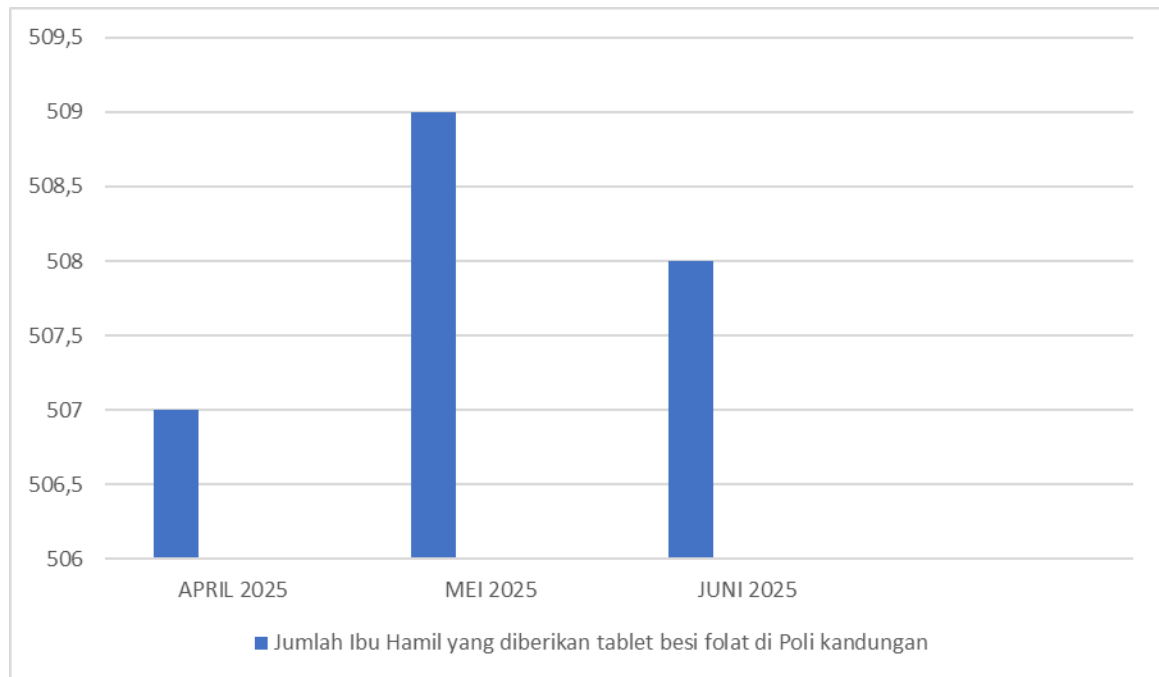
Bekerjasama dengan puskesmas setempat agar dapat melakukan pendampingan intervensi spesifik di posyandu disekitar wilayah rumah sakit dan melakukan pemantauan kepada balita stunting.

A. Pemberian Tablet Besi Folat bagi ibu hamil

Tabel 5.2 Distribusi Tablet besi folat pada Ibu Hamil di RS Prima Husada Malang

Bulan	APRIL 2025	MEI 2025	JUNI 2025
Jumlah Ibu Hamil yang diberikan tablet besi folat di Poli kandungan	507	509	508

Grafik 5.1 Jumlah Pemberian tablet besi folat pada ibu hamil Di RS Prima Husada Bulan April 2025



Analisis :

Pemberian asam folat diberikan kepada ibu hamil pada usia kandungan trimester pertama. Sedangkan pemberian tablet zat besi diberikan pada usia kandungan trimester 2 dan 3. Jumlah pemberian tablet besi folat turun dari sebelumnya 509 di bulan Mei menjadi 508 pada bulan Juni yang mendapat tablet besi folat untuk ibu hamil.

Rencana Tindak Lanjut:

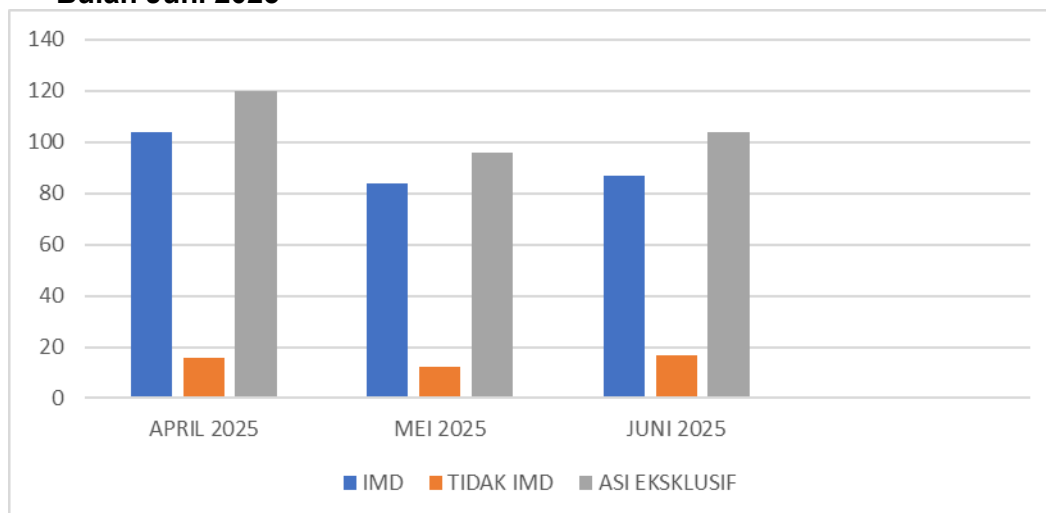
1. Koordinasi dengan tim farmasi untuk mendukung penyediaan tablet tambah darah, agar program suplementasi tablet tambah darah kepada ibu hamil terus berlanjut
2. Koordinasi dengan tim humas rumah sakit agar ibu hamil yang bergabung semakin banyak agar program suplementasi tablet besi folat semakin baik.

B. Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

Tabel 5.3 Jumlah Ibu Melahirkan yang Mendapat Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

No	Uraian	Jumlah Pasien		
		Bulan April 2025	Bulan Mei 2025	Bulan Juni 2025
1	IMD	104	84	87
2	Tidak IMD	16	12	17
3	Mendapat Konseling ASI Eksklusif	120	96	104

Grafik 5.2 Pelayanan IMD dan Konseling ASI Eksklusif di RS Prima Husada Bulan Juni 2025



Analisis :

1. Bayi yang dilakukan IMD pada bulan Juni sebanyak 87 bayi.
2. Kasus tidak dilakukan IMD pada bulan Juni 2025 meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu 17 bayi. Hal ini terjadi diiringi dengan masih adanya bayi lahir dengan berat <2500 gr sehingga tidak dilakukan IMD.
3. Pada bayi yang tidak dilakukan IMD memang tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan IMD dikarenakan BBLR yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
4. 100% ibu melahirkan telah mendapatkan edukasi menyusui. Untuk mendukung pemberian ASI secara eksklusif. Jumlah Ibu mendapat konseling ASI Eksklusif meningkat pada bulan Juni 2025 yaitu sebanyak 104 pasien.

Rencana Tindak Lanjut:

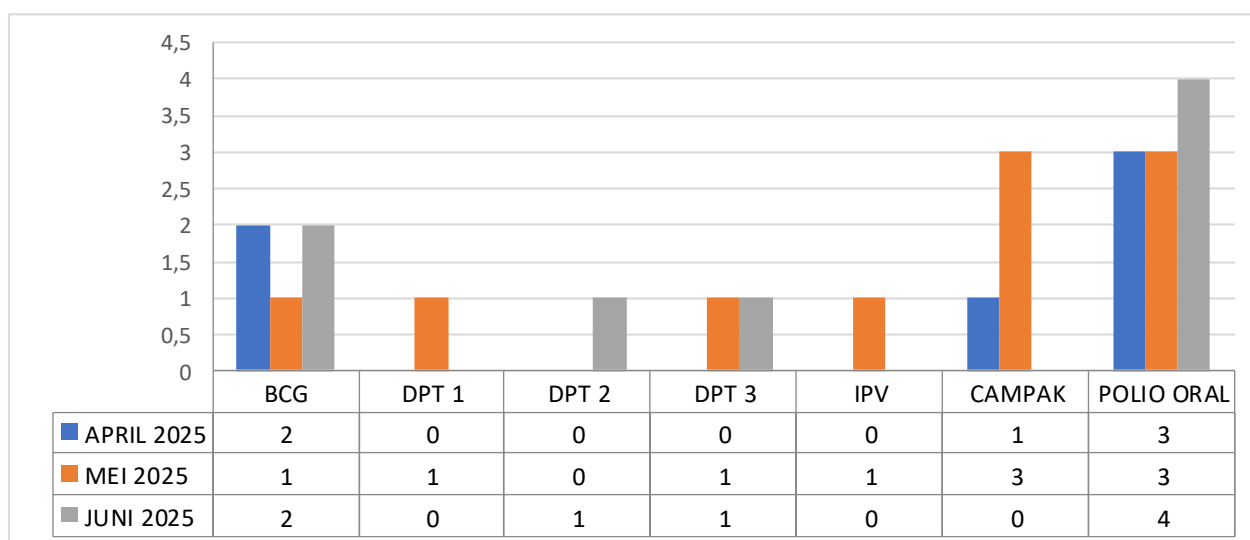
Tingkatkan koordinasi dengan dokter kandungan dan bidan rumah sakit dalam pemberian edukasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif serta mendokumentasikan bukti telah melakukan edukasi kepada ibu melahirkan pada lembar edukasi.

C. Jumlah Balita yang mendapat imunisasi

Tabel 5.4 Jumlah Balita yang mendapat imunisasi

No	Jenis Pelayanan	Jumlah		
		Bulan April 2025	Bulan Mei 2025	Bulan Juni 2025
1	BCG	2	1	2
2	DPT 1	0	1	0
3	DPT 2	0	0	1
4	DPT 3	0	1	1
5	DPT 4	0	1	0
5	IPV	1	0	0
6	Campak	1	3	0
7	Polio Oral	3	3	4

Grafik 5.3 Pelayanan Imunisasi Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juni 2025



Analisis:

1. Terdapat 2 balita yang melakukan imunisasi BCG di bulan Juni 2025.
2. Tidak ada bayi yang melakukan Imunisasi DPT 1, IPV, dan campak pada bulan Juni 2025.
3. Pada periode Juni 2025 terdapat 4 bayi yang melakukan Imunisasi Polio.
4. Terdapat 1 balita yang melakukan imunisasi DPT 2 dan DPT 3 di RS. Prima Husada Malang.

Rencana Tindak Lanjut :

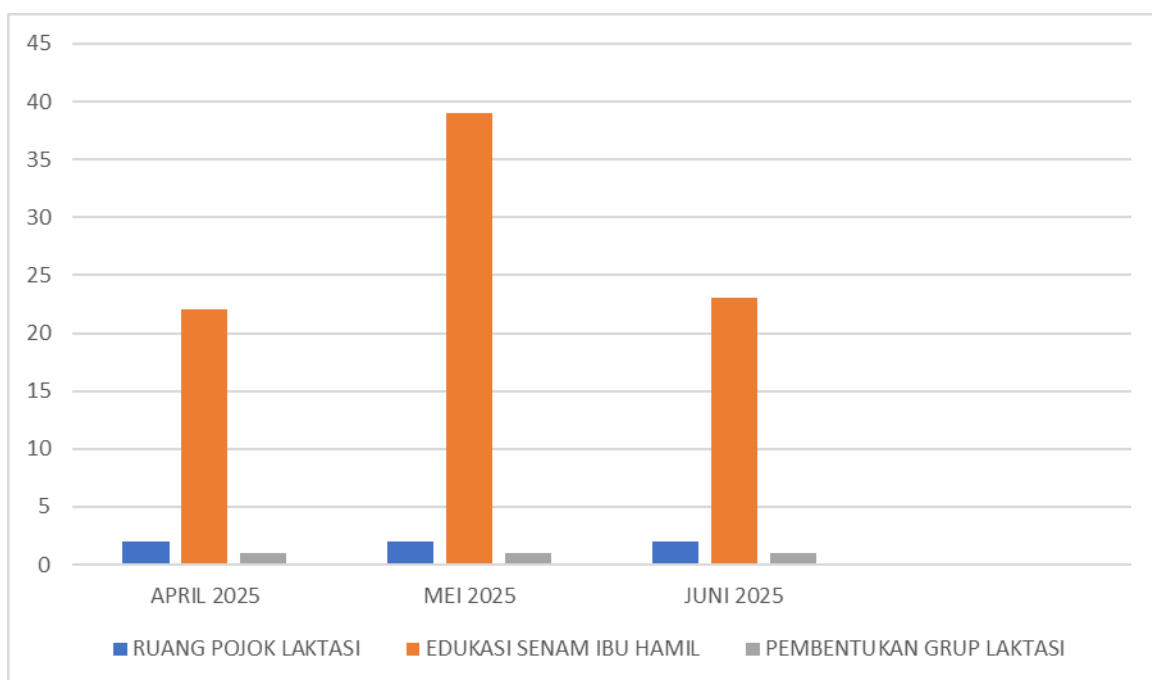
Melakukan promosi terkait pelayanan imunisasi, baik oleh bidan maupun dokter spesialis rumah sakit. Bekerjasama dengan pihak puskesmas untuk ketersediaan vaksin di RS.

D. Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi

Tabel 5.5 Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi

Kegiatan Penerapan Rumah sakit sayang ibu dan bayi	April 2025	Mei 2025	Juni 2025
Ruang Pojok Laktasi	2	2	2
Edukasi Senam Hamil	22	39	23
Pembentukan Grup Laktasi	1	1	1

Grafik 5.4 Senam Hamil Di Rumah Sakit Prima Husada Bulan Juni 2025



Analisis :

1. Pojok laktasi sudah tersedia untuk ibu dan bayi yang akan menyusui di wilayah Rumah Sakit Prima Husada Malang sebanyak 2 ruangan, di lantai 1 dan di lantai 2.
2. Grup Laktasi dibentuk untuk memberikan tips menyusui.
3. Pada bulan Juni edukasi pada senam ibu hamil dilakukan dengan memberikan penyuluhan Kekurangan Energi Kronis pada Ibu Hamil sebanyak 13 peserta senam ibu hamil dan 10 peserta pasien rawat jalan di poli obgyn.

Rencana Tindak Lanjut :

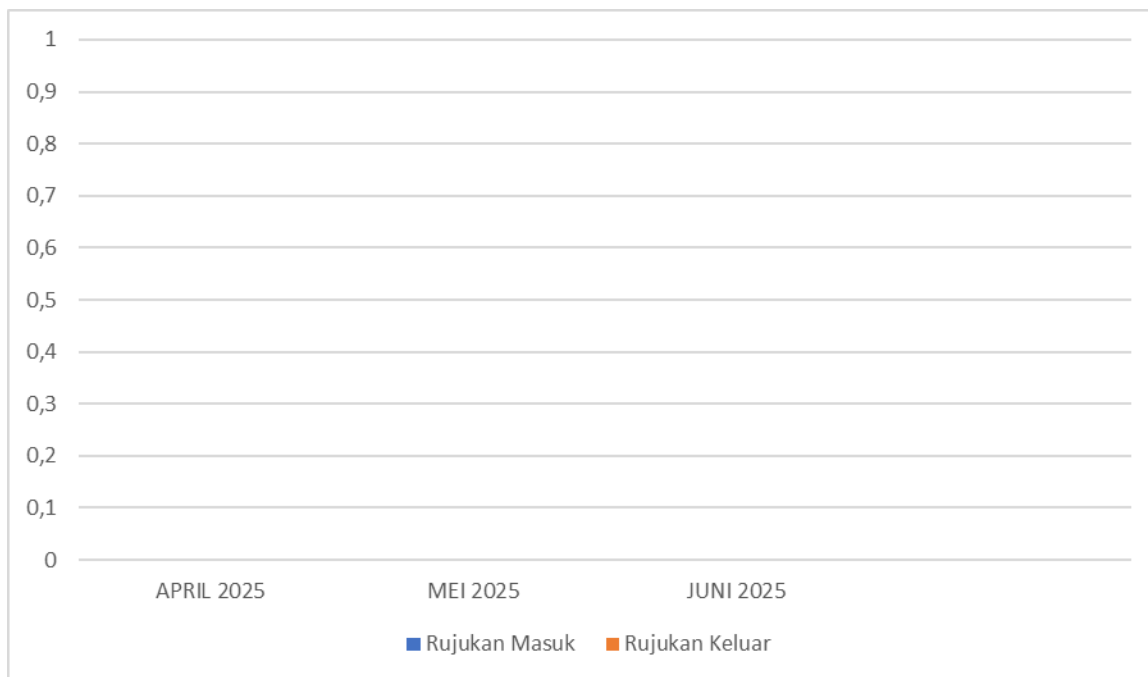
1. Mengajukan perlengkapan untuk keperluan menyediakan pojok laktasi yang nyaman bagi bayi, balita, dan ibu menyusui seperti popok dan tissue basah jika terdapat pasien atau pengunjung yang membutuhkan.
2. Melakukan edukasi mengenai pentingnya mengikuti senam ibu hamil pada ibu hamil yang tidak memiliki kondisi penyulit saat hamil.

E. Pelayanan jejaring rujukan kasus stunting dan wasting

Tabel 5.6 Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu Bayi

Rujukan Masuk				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Asal Rujukan
Februari	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-
	-	-	-	-
Rujukan Keluar				
Bulan	Nama PX	Usia	Diagnosa	Tujuan Rujukan
Februari	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-
	-	-	-	-

Grafik 5.5 Pelayanan jejaring rujukan kasus stunting dan wasting Bulan Juni 2025



Analisis :

Tidak Terdapat pasien stunting atau wasting yang dirujuk keluar RS maupun rujuk masuk RS.

Rencana Tindak Lanjut:

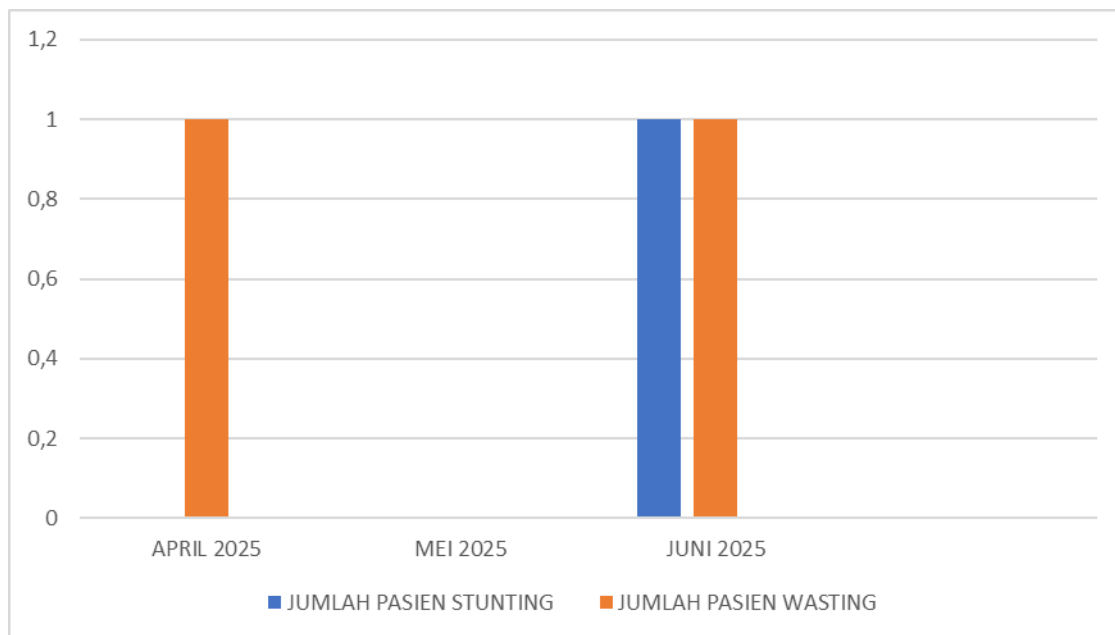
Perlu diadakan kerjasama lagi dengan puskesmas dan klinik faskes pertama untuk bekerjasama dalam menjangkau pasien stunting dan wasting.

1. Rumah Sakit sebagai pendamping klinis dan manajemen serta merupakan jejaring rujukan

Tabel 5.7 Jumlah Temuan Pasien Stunting dan Wasting di RS Prima Husada Malang

Bulan	April 2025	Mei 2025	Juni 2025
Jumlah Pasien Stunting	0	0	1
Jumlah Pasien Wasting	1	0	1

Grafik 5.6 Jumlah Temuan Pasien Stunting dan Wasting di RS Prima Husada Malang



Analisa :

Pada bulan Juni 2025 terdapat 1 pasien stunting dan wasting. Hal tersebut berkaitan dengan kebiasaan makan yang kurang adekuat pada pasien. Ibu pasien mengatakan anak suka makan namun kurang beragam, contohnya sekali makan nasi degan abon saja. Di mana kebutuhan energi anak tidak adekuat, makanan yang dimakan tidak dapat memenuhi kebutuhan energinya. Selain itu, aktivitas fisik anak sangat aktif sehingga makanan harus lebih beragam dan tinggi kalori dan protein. Berdasarkan berat badan menurut umur dan berat badan menurut tinggi badan pasien termasuk kategori *stunting* dan *wasting*.

Rencana Tindak Lanjut :

Tim Stunting dan Wasting RS Prima Husada telah melakukan kunjungan rumah pasien Bersama ahli gizi Puskesmas Lawang, bidan desa setempat, dan kader wilayah kerja.

F. Program Pemantauan dan Evaluasi

Program pemantauan dan evaluasi yang diberikan kepada pasien stunting dan wasting adalah dengan cara mengontrol pola makan, berat badan dan tinggi badan pasien pada saat kunjungan rumah pasien dan saat melakukan kunjungan kontrol *post KRS*.

Analisa :

Program pemantauan dan evaluasi pasien *wasting* dan *stunting* tetap dilakukan dan berjalan setiap harinya.

Rencana Tindak Lanjut :

Menghubungi petugas gizi dan melakukan kunjungan untuk melakukan pemantauan berat badan, tinggi badan, dan pola makan pada balita *wasting* yang ditemukan tim *stunting* dan *wasting* RS Prima Husada Malang.

Malang, 04 Juli 2025

Mengetahui

Ketua Tim Stunting dan Wasting

PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr.Fiona Paramitha, Sp. A



dr. Nur Mazidah

Supervisi Tim Stunting dan wasting

No.	Komponen yang dinilai	Standar	Dilakukan		Temuan	Tindak Lanjut
			Ya	Tidak		
INPUT						
1	Tersedia regulasi tentang program gizi terkait penurunan prevalensi stunting dan wasting	PROGNAS 4 EP 1	√			
2	Tersedia regulasi yang meliputi penetapan tim stunting dan wasting, Pedoman kerja tim stunting dan wasting, Program kerja tim stunting dan wasting	PROGNAS 4 EP 2	√			
3	Tersedia regulasi tentang sistem rujukan untuk kasus gangguan gizi yang perlu penanganan lanjut	PROGNAS 4 EP 3	√			
4	Tersedia Bukti pelaksanaan pendampingan intervensi dan pengelolaan gizi serta penguatan jejaring rujukan (pelaksanaan rujukan masalah gizi ke fasilitas kesehatan)	PROGNAS 4 EP 4.1.1	√			
5	Tersedia Bukti pelaksanaan pendampingan intervensi dan pengelolaan gizi serta penguatan jejaring rujukan (daftar pasien gangguan gizi yang dirujuk ke fasilitas kesehatan)	PROGNAS 4 EP 4.1.1	√			
6	Tersedia hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan	PROGNAS 4 EP 4.1.2	√			
7	Tersedia bukti pencatatan dan pelaporan kasus masalah gizi melalui aplikasi Eppgbm	PROGNAS 4 EP 4.1.2	√			
8	Tersedia materi edukasi tentang peningkatan efektifitas intervensi spesifik sebagai upaya penurunan prevalensi stunting dan wasting	PROGNAS 4 EP 4.1.1	√			
PROSES						

1	Terlaksananya program gizi terkait penurunan prevalensi stunting dan wasting	EP 4.1	√			
2	Terlaksananya pedoman kerja tim stunting dan wasting	EP 4.2	√			
3	Terlaksananya program kerja tim stunting dan wasting	EP 4.2	√			
4	Terlaksananya prosedur rujukan untuk kasus gangguan gizi yang butuh penanganan lebih lanjut	EP 4.2	√			
5	Terlaksana pelatihan tentang pelayanan pasien stunting dan wasting	EP 4.1.1		√		
6	Terlaksana program peningkatan efektifitas intervensi spesifik	EP 4.1.1	√			
7	Terlaksana penguatan sistem surveilans gizi	EP 4.1.2	√			
OUTPUT						
1	Tersedia UMANDOK rapat yang melibatkan Pimpinan RS dalam menyusun kegiatan tim penurunan stunting dan wasting dalam perencanaan RS	EP4.1	√			
2	Tersedia bukti pelaksanaan pendampingan intervensi dan pengelolaan gizi pasien stunting dan wasting	EP4.1.1	√			
3	Tersedia bukti tentang pelaksanaan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan beserta bukti daftar pasien stunting dan wasting yang di rujuk dan MOU dengan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan	EP4.1.1		√		
4	Tersedia bukti laporan dan hasil analisis pengukuran mutu meliputi evaluasi 1. Audit kesakitan, kematian 2. Pencatatan dan pelaporan gizi buruk dan stunting	EP4.1.1	√			

Kunjungan balita gizi buruk

NOTA DINAS

Dari : Chandrawati Mustikasari
Kepada : dr. Nur Mazidah
 : PLT Direktur RS Prima Husada Malang
Perihal : Laporan Kunjungan Balita Gizi Kurang (PROGNAS Penurunan
 : Prevalensi Stunting & Wasting)
Tanggal : 21 Juni 2025

Isi Nota Dinas : Kunjungan Balita Gizi Kurang (PROGNAS Penurunan
Prevalensi Stunting & Wasting)

Dasar : Elemen Penilaian Akreditasi RS (PROGNAS Penurunan
Prevalensi Stunting dan Wasting)

Maksud & Tujuan : Untuk menindak lanjuti temuan balita gizi kurang di RS Prima
Husada Malang dan untuk memenuhi Elemen Penilaian
Akreditasi RS (PROGNAS Penurunan Prevalensi Stunting dan
Wasting)

Waktu : 09.00 – Selesai WIB

Pelaksanaan : Edukasi Diet Balita Gizi Kurang & pengukuran BB, TB Balita

Nama Petugas : Chandrawati Mustikasari, S. Tr. Gz

**Daerah Tujuan / Instansi
yang Dikunjungi** : Puskesmas Lawang dan Rumah Balita Gizi Kurang (Jl.
Cokroaminoto RT. 003 RW. 010 Lawang)

Hadir Dalam Pertemuan : Kunjungan Balita Gizi Kurang

**Petunjuk / Arahkan yang
Diberikan (Materi)** : Materi Pemberian Makanan Padat Kalori dan Protein untuk
Tumbuh Kembang Anak

**Masalah / Temuan di RS
PHM yang Relevan
dengan Materi** : Balita masuk (Rawat inap) dengan kondisi berat badan dan
tinggi badan kurang. Masuk RS dengan diagnosa TF

**Saran / Tindakan untuk
RS hasil dari Pelatihan** : Mengukur BB dan TB balita secara berkala

Nama Karyawan

Tembusan : PLT Direktur RS Prima Husada Malang

DOKUMENTASI



SURAT TUGAS
NOMOR: 1153/E-ST/DIR/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : dr. Nur Mazidah
Jabatan : Direktur RS Prima Husada

Dengan ini menugaskan kepada :

Nama : Chandrawati Mustika, S.Tr.Gz
Jabatan : Ahli Gizi
Hadir dalam acara : Pemantauan Tumbuh Kembang Balita Gizi Kurang Oleh Tim
Stunting dan Wasting RS Prima Husada
Hari / Tanggal : Sabtu / 21 Juni 2025
Waktu : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Balai Dusun Lawang
Jl. Cokroaminoto RT. 003 RW. 010 Lawang – Malang

Demikian Surat Tugas ini dibuat, harap melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Malang, 20 Juni 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

Penyuluhan

